

中药外治治疗慢性手部湿疹古方探析

林正¹ 潘思懿¹ 吴炫¹ 周秋君¹ 叶瑜剑² 林萍² 曹毅³

1. 浙江中医药大学第一临床医学院 杭州 310053 2. 杭州市第三人民医院 3. 浙江省中医院

摘要: [目的] 总结手部皮肤之生理, 归纳治疗慢性手部湿疹的外治古方, 探讨各方所适之病机、针对之症状、剂型之活用、药物之配伍。[方法] 查阅《黄帝内经》《外科正宗》《医宗金鉴》《外科全生集》等经典书籍, 结合现代药理学研究, 系统归纳手部皮肤的生理、慢性手部湿疹的病机以及外治古方的“理、法、剂、药、用”。[结果] 手部皮肤与诸脏腑经络关系紧密, 尤其与心、脾、肺、肾四脏关系密切, 又为十二经阴阳转换之地, 故起病时往往病机复杂, 如血气凝滞、湿蕴生虫、风血皆燥、太少湿热、燥湿互结, 皆可致慢性手部湿疹之病。外治方中汤剂有长于清热燥湿之二矾汤, 主以杀虫祛湿之苦参汤; 散剂有擅于清润相合之玉肌散, 长于攻毒化瘀之如圣散; 膏剂则主以养血润肤之润肌膏, 擅长滋攻并用之三油膏, 用于攻毒燥湿之藜芦膏, 主取去瘀生新之红油膏; 丸剂有同擅于攻毒润肤之绣球丸、诸疮一扫光。古方改进可从探究机制、改良剂型、增减药方等方面入手。[结论] 中药古方剂型各异, 功效广博, 配伍规整, 以“滋、化、燥”三法治疗慢性手部湿疹。研究古方对慢性手部湿疹的临床治疗和研究具有指导价值, 对剂型的改进也有一定的启迪作用。

关键词: 慢性手部湿疹; 外治; 中药; 古方; 《外科正宗》; 《医宗金鉴》; 《太平惠民和剂局方》; 《外科全生集》

中图分类号: R658 文献标志码: A 文章编号: 1005-5509(2024)12-1550-07

DOI: 10.16466/j.issn1005-5509.2024.12.012

Analysis of Traditional Chinese Ancient Prescriptions for External Treatment of Chronic Hand Eczema LIN Zheng, PAN Siyi, WU Xuan, et al *The First Clinical Medical School of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou(310053), China*

Abstract: [Objective] To summarize the physiology of hand skin, summarize the ancient external treatment of chronic hand eczema as an indication, and discuss the pathogenesis, symptoms, use of dosage forms and drug compatibility of each party, so as to lay a foundation for future clinical research. [Methods] Through the literature review of *Huangdi's Inner Classic*, *Orthodox Manual of External Diseases*, *The Golden Mirror of Medicine*, *Life-saving Manual of Diagnosis and Treatment of External Diseases* and other traditional Chinese medicine books, combined with modern pharmacology, it systematically summarized the physiology of hand skin, the pathogenesis of chronic hand eczema and the “principle, method, prescription, medicine and application” of external treatment of ancient prescriptions. [Results] The skin of the hand is closely related to the viscera and meridians, especially the four viscera of the heart, spleen, lung and kidney, and is also the place where Yin and Yang of the twelve channels change. Therefore, the pathogenesis is often complex when the disease, such as blood stagnation, wet insects, wind and blood dryness, damp heat in Taiyin and Shaoyang, dry and wet interjunction, can cause chronic hand eczema disease. This article summarizes the treatment of the external prescription includes Decoction, such as Erfan Decoction clearing heat and drying dampness, Kushen Decoction killing insects and removing dampness; Powder such as Yuji Powder good at clearing and moistening, Rusheng Powder attacking poison and removing blood stasis; Ointment such as Runji Ointment nourishing blood and skin, Sanyou Ointment nourishing and allacking poison, Lilu Ointment attacking poison and drying dampness, Hongyou Ointment removing stasis and producing new; Pill such as Xiuqiu Pill and Zhuchuang Yisaoguang attacking poison and moisturizing skin. This article also puts forward several directions for the improvement of ancient prescriptions, including exploring the mechanism, improving the dosage form, increasing or decreasing the prescription, etc. [Conclusion] Traditional Chinese ancient prescriptions have different dosage forms, wide efficacy, regular compatibility, revealed the treatment of chronic hand eczema “moistening, activating blood, drying dampness” three methods. Studying traditional Chinese ancient prescriptions has guiding value for the clinical treatment and research of chronic hand eczema, and also has a certain enlightening effect on the innovation of dosage forms.

Key words: chronic hand eczema; external treatment; traditional Chinese medicine; ancient prescriptions; *Orthodox Manual of External Diseases*; *The Golden Mirror of Medicine*; *Prescriptions of the Bureau of Taiping People's Welfare Pharmacy*; *Life-saving Manual of Diagnosis and Treatment of External Diseases*

基金项目: 浙江省中医院曹毅名中医工作室项目(GZS2020022); 2023 年度研究生拔尖创新人才培养资助项目(721100G00736); 杭州市农业与社会发展科研项目(20220919Y015); 国家中医药管理局科技司-浙江省中医药管理局共建科技计划项目(GZY-ZJ-KJ-23088)

Fund projects: Zhejiang Hospital of Traditional Chinese Medicine CAO Yi Famous Chinese Medicine Expert Studio Project (GZS2020022); 2023 Graduate Students Top Innovative Talent Training Funding Project(721100G00736); Hangzhou Agricultural and Social Development Research Project(20220919Y015); Science and Technology Department of State Administration of Traditional Chinese Medicine-Zhejiang Provincial Administration of Traditional Chinese Medicine Co-construction Project(GZY-ZJ-KJ-23088)

通信作者: 曹毅, E-mail: caoyi1965@163.com

慢性手部湿疹是一类以皲裂、鳞屑、角化过度、苔藓样变、皮肤肥厚为主要表现的手部湿疹样皮炎,持续时间大于 3 个月。西医治疗以外用糖皮质激素和钙调磷酸酶抑制剂为主,但存在较多弊端,例如长期使用引发皮肤萎缩和毛细血管扩张、中重度病例局部治疗无效、停药后皮疹反复发作等^[1]。研究表明,约有 14.5% 的患者终身受慢性手部湿疹的影响,这给患者带来了较大的困扰^[2]。中药外治治疗慢性手部湿疹由来已久,并取得了良好的疗效,但治疗时中药、剂型、用法的选择差异较大。本文从“理、法、剂、药、用”入手,对治疗慢性手部湿疹之中医外治古方作一概述探析,旨在为临床治疗提供新的思路。

1 手部皮肤的生理

1.1 手部皮肤与脏腑

1.1.1 心主神明,触物传感皆属于心 中医认为心主神明,司精神,《素问·灵兰秘典论》曰“心者,君主之官,神明出焉”“任物者,谓之心”“诸痛痒疮,皆属于心”。手的灵巧活动受心的支配,手部皮肤亦将所触物体之特性传导于心,心主神明功能的异常会影响手部皮肤的生理功能。研究表明,手部湿疹发病和情绪状况与睡眠状况有紧密的联系^[3],此之谓“主不明则十二官危”。同时手部皮肤疾病也会导致心主神明功能失常,有报道指出慢性手部湿疹会导致患者的焦虑抑郁状态,辅助心理疗法较单纯药物治疗取得了更好的疗效^[4]。

1.1.2 精血濡肤,脾心肺肝各司其职 脾主运化,又主四肢,将水谷精血运化充养四肢皮肤,此即《素问·经脉别论》所云:“脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。水精四布,五经并行。”心主血脉,推动周身血液循环中;肺主治节,调节全身气机,助心脾以行精血;肝主藏血,又主疏泄,藏泻有度,血行无碍。手部皮肤因其位于四末的特殊位置,尤赖脾脏输注精血之功,精血灌注充盈,则手部皮肤润泽,正气充足,抗邪有根。

1.1.3 水谷润肤,须六腑受盛传化 精血有濡养肌肤之功,然化生精血则需六腑通力协作,先化生水谷精微,再奉心化赤而为血。胆为中正之府,有“凡十一脏取决于胆”之说,各脏需胆决断协调,以维持和控制气血的正常运行;胃主受纳腐熟水谷;小肠主分清别浊;大肠主传导糟粕;膀胱主排泄水液;三焦主通运精微。若六腑受盛传化之功能有异,水满则为

湿,皮肤可见渗出水疱;水缺则为燥,皮肤可见干燥皲裂;气余便是火,则觉皮肤瘙痒钻刺。研究报道,肠道中普拉梭菌和阿克曼菌的增多及唾液链球菌的减少,与湿疹等皮肤病有密切的联系^[5],湿疹会导致肠道的通透性增加^[6],这也从现代科学的角度印证了六腑与手部肌肤密切的联系。

1.1.4 肌肤腠理,赖肺肾主其开阖 腠理是皮肤沟通内外的通道,即《医宗金鉴》所言:“腠者,一身气隙,血气往来之处,三焦通会元真之道路也。”^[7]^[20] 腠理之功能其制在肺,其本在肾。肺主皮毛,司全身腠理之呼吸进出,故曰“其制在肺”。肾为先天之本,主藏精纳气,《灵枢·本脏》有言“肾合三焦膀胱,三焦膀胱者,腠理毫毛其应”,腠理的肥密离不开肾气的濡养,故曰“其本在肾”。若肺失其约,肾失其养,腠理当开不开,内邪无以出表,腠理当闭不闭,时时易感外邪。

1.2 手之皮部与经络 经络是运行周身气血、联络上下肢节、沟通内外脏腑、传导信息的道路系统,人体经脉及其络脉按其循行路线在体表各有其对应区域,即为皮部。《素问·皮部论》曰“欲知皮部,以经脉为纪者,诸经皆然”,皮部受相关脏腑经络的濡养,其色泽、枯荣能反映相关脏腑的疾病。手部为六经阴阳交汇之地,手阳明大肠经起于食指商阳,手太阳小肠经起于小指少泽,手少阳三焦经起于环指关冲,手太阴肺经止于拇指少商,手少阴心经止于小指少冲,手厥阴心包经止于中指中冲。由此可见,手部为气血阴阳转换、诸脏腑变见之地,这也形成手部皮肤独特的病理特点:一为接触频繁,易于受邪;二为六经交汇,病机复杂;三为地处四末,气血灌注不易,故易虚易实,易湿易燥。

2 慢性手部湿疹的病机法度

2.1 中医之见 历代文献中并无手部湿疹的诊断命名,基于慢性手部湿疹皲裂、肥厚、鳞屑等主要症状,查阅中医外科经典专著,认为中医之“鹅掌风”“顽风”“疥癣”等与慢性手部湿疹类似。关于其病机,主要有以下几个方面。

2.1.1 寒热交攻,血气凝滞 《外科正宗·卷十·鹅掌风第七十一》载:“鹅掌风由于阳明胃经火热血燥,外受寒凉所凝,致皮枯槁……初起红斑白点,久则皮肤枯厚、破裂不已,二矾汤熏洗即愈。”^[8]^[26] 陈实功认为,手部湿疹起于阳明经火热,热邪煎熬致血燥内起,加之感受寒邪,寒热交攻,脾胃失运,气血凝滞,不能濡

养,则成寒热交攻、脾胃失运所致血滞之象。

2.1.2 外感风湿,久而化虫 《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·手部·痼疮》曰:“此证生于指掌之中,形如茱萸,两手相对而生。亦有成攒者,起黄白脓疱,痒痛无时,破津黄汁水,时好时发,极其疲顽,由风湿客于肤腠而成。”^{[7]810} 吴谦认为,手部湿疹生于外感风湿,急性期可见脓疱、瘙痒,久之湿伤脾胃,生为虫毒,如《金匱要略·百合狐惑阴阳毒》中所言“蚀于喉为惑,蚀于阴为狐”,此即虫毒蚀于手而发为皮疹。

2.1.3 血燥内生,兼有风燥 《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·手部·鹅掌风》有云:“此证生于掌心,由生杨梅余毒未尽,又兼血燥,复受风毒,凝滞而成。初起紫白斑点,叠起白皮,坚硬且厚,干枯燥裂,延及遍手。外用二矾散洗之,三油膏擦之。”^{[7]810} 吴谦认为,此为邪毒、血燥、风毒三者合而为病,邪毒未尽,余热未清,久之则煎灼血液,精枯血燥,另合风燥之邪,同气相求,内外合邪,发为本病。

2.1.4 少阳火化,太阴湿生 《外科正宗·卷十·疥疮论第七十三》曰:“夫疥者,微芒之疾也……不生于身,独攻于手者又何也? 疥曰:手掌乃太阴湿土所主,手心又少阳相火所司,土能生我,火能化我,此生皆赖湿土阳火所化,故生者必自出于手掌……发痒钻刺,化化生生,传遍肢体,近则变为疥癬,久则变成顽风,多致皮肤枯槁,浸淫血脉,瘙痒无度,得汤方解。”^{[8]21} 陈实功亦认为,慢性手部湿疹起于脾土之湿热,脾主运化水谷精血至掌部,其湿热亦留存于手掌,其“形随湿化,动随火化”,则发为皮疹。

2.1.5 血虚化燥,燥湿互结 手部湿疹急性期以渗出、水疱等为主要症状,慢性期则以干燥、皲裂等为主要症状。现代医家将急性期多辨为风热、脾虚湿蕴、湿热等,慢性期多辨以血虚风燥^[9]。其中多数医家认同国医大师路志正关于湿燥关系的观点,路老认为人体水液为一个整体,湿气者多,则能濡养之津液即少,最终亦能形成燥邪,此之谓“湿多燥亦多”^[10]。而在手部湿疹进程中,初期以湿为主,故多渗出;后期燥湿互结,发病时皮疹既有燥的干裂之性,又有湿的缠绵之能,迁延难愈。

2.2 现代医学研究进展

2.2.1 病因与分型 慢性手部湿疹病因复杂,包括遗传、环境和暴露等因素的相互作用,有明确刺激物

接触史或斑贴试验阳性的患者考虑外源性的病因,无刺激物接触史或病因不明的患者考虑内源性的病因^[1]。疾病分型主要包括刺激接触性皮炎(irritant contact dermatitis, ICD)、过敏接触性皮炎(allergic contact dermatitis, ACD)、特应性手湿疹等,有研究表明特应性手湿疹占有慢性手部湿疹的 50% 以上^[11]。

2.2.2 发病机制 慢性手部湿疹的发病机制尚不明确,目前广泛认为表皮屏障功能的缺失是慢性手部湿疹发病的关键之一。表皮屏障的主要作用为保护皮肤防止水分流失以及减少过敏原和刺激物的渗透,其功能的失常可能导致皮肤水分含量发生变化,以及皮肤的敏感性和刺激性提高等^[12]。慢性手部湿疹的免疫过程因主要触发因素而异。如一般认为 ICD 由刺激物产生的细胞毒作用引起,ACD 以 IV 型超敏反应为核心反应机制^[13],特应性手湿疹以 Th2/Th22 免疫反应为主,并伴有内源性因素,如紧密连接缺损和经表皮失水增加,从而损害表皮屏障的完整性^[14]。亦有研究发现,聚丝蛋白基因突变、金黄色葡萄球菌感染等是特应性手湿疹的影响因素^[15]。

2.2.3 主要治疗 目前慢性手部湿疹的治疗主要着重于预防与局部用药。在预防调护的环节,避免接触刺激物和润肤保湿成为核心环节,富含脂类的润肤剂有利于皮肤屏障的修复^[14]。局部用药以糖皮质激素以及钙调磷酸酶抑制剂为主^[1],但长期使用存在皮肤萎缩、毛细血管扩张、中重度病例通常无效等弊端。另一治疗的难点在于,在生活中难以避免频繁洗手和接触外物,从而容易降低疗效^[14]。

3 酌古御今,古籍中治疗慢性手部湿疹的外用制剂

早在《黄帝内经》时期,中医便有“浸淫疮”“湿疮”的定义。中医治疗慢性手部湿疹源远流长,但其药物、剂型、用法各异,主要有汤剂熏洗、散剂、膏剂、丸剂四类,各有优劣。见表 1。汤剂熏洗是把中药混合,加水煎煮后,去渣取汁,熏蒸使用。优点在于通过溶解药物,使药物分子游离于水中,易于经皮肤屏障吸收和利用,可以根据需要精确配制,确保药物剂量准确。但对慢性手部湿疹患者而言,汤剂缺少对皮肤屏障的保护功能和滋润皮肤的作用。

散剂是将中药研磨成细粉后,按照一定比例混合,制成的干燥粉状剂型。优势在于对疮面能起到一定的保护作用,并且使用方便、制备简单。但散剂

表 1 古籍中慢性手部湿疹相关外用制剂整理

剂型	名称	出处	药物
汤剂	二矾汤	《外科正宗·卷十·鹅掌风第七十一》	白矾、皂矾、儿茶、侧柏叶
汤剂	苦参汤	《严氏济生方·疥癣门·疮疥论治》	苦参、蛇床子、白矾、荆芥穗
散剂	玉肌散	《外科正宗·卷十一·手足破裂第九十九》	绿豆、滑石、白芷、白附子
散剂	如圣散	《太平惠民和剂局方·卷之八·治疮肿伤折》	蛇床子、黄连、铅粉、水银
膏剂	润肌膏	《外科正宗·卷十一·手足破裂第九十九》	麻油、当归、紫草
膏剂	三油膏	《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·鹅掌风》	牛油、柏油、香油、朱砂、铅粉、麝香
膏剂	藜芦膏	《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·痼疮》	藜芦、苦参、松香、雄黄、猪油
膏剂	红油膏	《外科全生集·卷四·敷药类》	砒霜、麻油
丸剂	绣球丸	《外科正宗·卷十·疥疮论第七十三》	樟脑、轻粉、川椒、枯矾、水银、雄黄、枫子肉
丸剂	诸疮一扫光	《外科正宗·卷十·疥疮论第七十三》	苦参、黄柏、烟胶、木鳖子、蛇床子、川椒、明矾、枯矾、硫黄、枫子肉、樟脑、水银、轻粉、砒霜

对使用药物有严格要求,且对于角质增厚的慢性手部湿疹患者,药力可能难以透过皮肤屏障。

膏剂是指将中药与基质混合,制成膏状制剂。膏剂优势在于对于皮肤有滋润和保护的作用,且药力平缓持续,用法也较为简单,在慢性手部湿疹中使用广泛。但膏剂一旦制成,药味相对固定,加减较为不易。

丸剂是指将中药材研磨成粉末,加入适量辅料,按照一定比例混合后制成的固体剂型。丸剂的优点是“丸者缓也”,药性释放相对缓慢平稳,针对慢性疾病有较好的疗效,丸剂中富含的油质对皮肤也有保护和滋润作用,并且易于携带和储藏,使用简便。丸剂的缺点一为吸收效率差,相对其他剂型不易透过皮肤屏障;二为丸剂中多含有重金属成分,有一定的毒性,部分患者有二次致敏的可能。

3.1 汤剂

3.1.1 二矾汤 出自《外科正宗·卷十·鹅掌风第七十一》。陈实功^{[8]269}认为“鹅掌风由于阳明胃经火热血燥,外受寒凉所凝,致皮枯槁”,拟二矾汤治疗。主要药物:白矾、皂矾(各四两),儿茶(五钱),侧柏叶(半斤)。用法:用水十碗,同上药四味煎数滚候用。先用桐油搽抹患上,以桐油蘸纸拈点着,以火焰向患上熏之;片时方将前汤乘滚贮净桶内,手架上用布盖,以汤气熏之,勿令泄气;待微热倾入盆内,蘸洗良久,七日忌下汤水。方中白矾性酸、涩、寒,皂矾性酸、凉,寒凉之性可解阳明火热,酸涩之性收湿敛疮,二矾同用,更增解毒燥湿止痒之功;儿茶性苦、涩、平,

收湿敛疮之余更可生肌敛口;侧柏叶性苦、涩、寒,凉血之余更可轻身益气,又有生发之功。全方共奏清热燥湿之功,更有除旧生新之力,加以熏洗之法,主要针对皲裂、干燥的症状。

3.1.2 苦参汤 出自《严氏济生方·疥癣门·疮疥论治》。书中将苦参汤与当归饮子归于疮疥门,条文如下:“治心血凝滞,内蕴风热,发见皮肤遍身疮疥,或肿,或痒,或脓水浸淫,或发赤。”^[16]严氏认为,对于气血凝滞内有湿热者,可予苦参汤治疗。具体方药如下:苦参、蛇床子、白矾、荆芥穗(各等分)。用法:上四味煎汤,放温洗。方中以性苦寒的苦参为君,主以杀虫燥湿、清热止痒,加以辛苦温之蛇床子,更增杀虫止痒之功;白矾性酸、涩、寒,主收敛、祛湿;荆芥辛温,取透疹消疮之功,又可散风。全方寒热互平,主以杀虫,辅以收敛消疮,主要针对瘙痒、渗出、浸润、红斑的症状。

3.2 散剂

3.2.1 玉肌散 出自《外科正宗·卷十一·手足破裂第九十九》。陈实功^{[8]294}认为手足皲裂乃因气血不能养荣,拟玉肌散治之。主要药物:绿豆(半升),滑石、白芷、白附子(各二钱)。用法:共为细末,每用三匙,早晚汤调洗患上。方中绿豆性甘寒,有清热解毒、养阴生津之功;滑石性甘淡寒,一可保护皮肤黏膜,二可收湿敛疮;白芷性辛温,有燥湿止痒之功;白附子性辛、温,能解毒散结,《本草备要》中云“能治面上百毒,亦可作面脂”^[17],现代药理学亦发现,白附子主要化学成分包括脂肪酸^[18],对慢性手部湿疹有润燥和保

林正,等:中药外治治疗慢性手部湿疹古方探析

护作用。全方清润结合,保护作用强,主要针对皲裂、干燥的症状。

3.2.2 如圣散 出自《太平惠民和剂局方·卷之八·治疮肿伤折》,书中述此方:“治肺脏风毒攻发皮肤,血气凝涩,变生疥疮瘙痒,搔之,皮起作痂,增展牵引,连滞不瘥。”^[19]其所治为血气凝涩所致之疥疮瘙痒。主要药物:蛇床子(半两),黄连(去须,三分),胡粉(结砂子,一两),水银(同胡粉点水研令黑。一分)。用法:上件药,以生麻油和稀滑。每用药时,先以盐浆水洗疮令净,后以药涂之,干即便换。方中蛇床子性寒、甘、苦,主以祛湿解毒,兼能止痒;黄连味苦性寒,可清热燥热,现代研究证实黄连具有抗菌和抗炎的作用^[20],可能对慢性手部湿疹皮肤有保护作用;铅粉,性辛、寒,具有清热解毒、疗痈肿烂疮之功,但铅粉对神经系统具有损害作用^[21],使用时需斟酌;水银性辛、寒、有毒,与铅粉作用类似,均具有攻毒之功,又可止痒;加以麻油调之,润肌护肤。全方以攻毒拔毒为基础,兼顾止痒润肌,主要针对瘙痒、肥厚、浸润的症状。

3.3 膏剂

3.3.1 润肌膏 出自《外科正宗·卷十一·手足破裂第九十九》^{[8]294}。理法与前文玉肌散同出一处,此处不再赘述。主要药物:麻油四两,当归五钱,紫草一钱。用法:用麻油四两、当归五钱、紫草一钱同熬,药枯滤清,将油再熬,加黄蜡五钱化尽,倾入碗内,顿冷搽擦患上。方中当归性辛、甘、温,取其补血活血、养血润肤之效;紫草味甘、咸、寒,具有凉血活血、解毒透疹之功;麻油则润肌养肤。全方以润为主,与前方玉肌散相配,加内服当归饮子,共奏养血润肤之功。

3.3.2 三油膏 出自《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·鹅掌风》。吴谦^{[7]810}认为,该病由邪毒、血燥、风毒三者合病而成,治以三油膏。主要药物:牛油、柏油、香油、朱砂(各一两),铅粉、麝香(研细,各二钱)。用法:将三油共合火化,入黄蜡一两,溶化尽,离火;再入朱、麝、铅粉等末,搅匀成膏。搽患处,火烘之,以油干滋润为度。方中以三油为名,即牛油、柏油、香油,享润血护肤之力,柏油又可清解热毒;朱砂味辛、性温、有毒,与辛寒之铅粉相配,既可燥湿止痒,又可以毒攻毒,两擅其功,又无助热之弊;麝香性辛温,能解风毒、通经络。全方以滋为主,以攻为辅,对干燥、皲裂、肥厚的症状有较好的疗效。

3.3.3 藜芦膏 出自《医宗金鉴·外科心法要诀·卷六十八·痼疮》。如前文所言,吴谦^{[7]810}认为,慢性手部湿疹可生于外感风湿,久则湿生虫毒,治以藜芦膏。主要药物:藜芦、苦参(各一两)。用法:猪脂油八两,将二味炸枯,滤去渣,入松香一两溶化开,离火,再加枯矾末、雄黄末各一两。搅匀,候温涂之,以痊为度。方中以藜芦、苦参主要配方,苦辛寒之藜芦与苦寒之苦参共有燥湿杀虫攻毒之力,虽本草明言藜芦、苦参相反,然外用与内服有异,故仍用之;再加猪油以润泽肌肤;用温苦甘之松香既可祛风燥湿拔毒,又有油脂润泽之力;再加酸寒之枯矾与辛苦温之雄黄,增杀虫祛湿之力,枯矾更可生肌化腐,然两药有毒,使用宜慎。全方攻虫与燥湿并重,针对脓疱、渗出、瘙痒等症状。

3.3.4 红油膏 出自《外科全生集·卷四·敷药类》。王维德^[22]于《外科全生集》中仅仅提及红油膏“治鹅掌风及一切风症”,以方测证,可能是治疗风湿引起的慢性手部湿疹。主要方药:砒霜(一钱)。用法:敲细如粳,以麻油一两,煎至砒枯烟绝为度,去砒留油。凡有风之处,每日以烘油擦。方中以辛、大热、有剧毒之砒霜为主药,取其蚀疮去腐之功,加以麻油润肤。全方取去腐生新之意,可能对角质层增厚的角化型慢性手部湿疹有效。

3.4 丸剂

3.4.1 绣球丸 出自《外科正宗·卷十·疥疮论第七十三》。如前文所言,陈实功认为太阴湿热内生,久之亦可产生本病,治以绣球丸^{[8]270}。主要药物:冰(樟脑)、轻粉、川椒、枯矾、水银、雄黄(各二钱),枫子肉(一百枚,另碾)。用法:治一切干湿疥疮及脓窠烂疮,瘙痒无度者效。以上共为细末,同大枫子肉再碾和匀,加地沥青一两化开,和药搅匀,作丸圆眼大,于疮上擦之。方中以辛温之樟脑、雄黄、川椒辟湿止痒杀虫;加辛寒有毒之轻粉、水银,酸寒之枯矾,清热除湿,又可敛疮生肌;枫子肉乃疮家要药,性辛、甘、热,《本草汇言》曰“此物质润性燥。濒湖方治疮疥,仅供外涂,能润皮肤,杀虫止痒。不堪服食”^[23],枫子肉质润性燥之性,正合慢性手部湿疹“湿多燥亦多”之病机。全方以清除湿热为主,不忘润肤护肤,主要针对瘙痒、皲裂、干枯的症状。

3.4.2 诸疮一扫光 出自《外科正宗·卷十·疥疮论第七十三》^{[8]270}。本方理法与绣球丸同出一处,故不

林正,等:中药外治治疗慢性手部湿疹古方探析

再赘述。主要药物:苦参、黄柏(各一斤),烟胶(一升),木鳖子、蛇床子、川椒(蜀椒)、明矾、枯矾、硫黄、枫子肉、樟脑、水银、轻粉(各二两),砒霜(五钱)。用法:此药凡治痒疮,不论新久及身上下,或干或湿,异类殊形,但多痒少痛者,并宜用之,俱各有效。共为细末,熟猪油二斤四两,化开入药搅匀,作丸龙眼大,瓷瓶收贮。用时搽擦患上,二次即愈。方中以绣球丸组成为基础,加用苦寒之黄柏、苦参增强清利湿热之力;湿为阴邪,加辛温之木鳖子、蛇床子、川椒更助祛风除湿,蛇床子兼可止痒;更加熟猪油以润燥护肤。全方药力较绣球丸犹有过之,故敢言“诸疮一扫光”。

4 中药外治法的临床应用

4.1 现代中医用法 现代中医使用古方或改进古方治疗慢性手部湿疹者取得了一定疗效。陈思文^[24]研究表明,润肌膏改善慢性手部湿疹患者的皮损及症状有效,其疗效与复方氟米松软膏相当,复发率更低,无明显不良反应。赵萌^[25]研究表明,加味二矾汤浸泡后,手部亚急性湿疹患者的皮损、瘙痒状况和生活质量均有改善,其疗效与醋酸曲安奈德乳膏相当,复发率低,不良反应较少。现代中医自拟外治方治疗慢性手部湿疹者亦多。吴怡峰等^[26]研究提示,自拟疯油膏(轻粉、广丹、朱砂、麻油、蜂蜡)热烘治疗慢性角化型手部湿疹疗效超过糠酸莫米松乳膏。魏璠等^[27]研究显示,自拟润燥止痒方(炒蒺藜、白藜、五倍子、炒王不留行)治疗慢性角化型手部湿疹疗效优于丁酸氢化可的松乳膏。这些案例均可说明,中药外治治疗慢性手部湿疹的疗效较好,不良反应更少,潜力值得挖掘。

4.2 中药外治法的改良方向

4.2.1 改善药方 如上文所述,大量中药外治方中均用了诸如铅粉、明矾、砒霜的有毒药物,这些药物虽然有独特的蚀疮生肌、去腐生新的功效,但其毒副作用也需要关注,寻找替代物、减小剂量、减轻毒性俱可作为改良思路。此外,可以结合现代药理研究结果,在药方中加入针对湿疹发病机制的药物,疗效确切,可使患者从中获益。如研究证明,马齿苋能下调大鼠湿疹模型的肿瘤坏死因子- α 、白细胞介素-4水平,通过抑制相关炎症因子的表达,调节免疫平衡,并能修复受损表皮屏障^[28]。

4.2.2 改良剂型用法 研究指出,小分子药物可能

更容易通过角质增生的皮肤屏障,从而使慢性手部湿疹患者获益^[29]。在保证疗效的情况下提取中药小分子,可能是中药外用制剂未来重要的发展方向。在使用外用制剂时,剂型的选择尤为重要。例如中药汤剂熏蒸可以提升皮肤的水合度,从而促进皮肤对药物的吸收^[30]。利用现代技术改善剂型,增加中药的吸收效率是中药外治改良的方向之一。中药外治古法往往比较繁琐,而当下社会生活节奏较快,如何在保证吸收效率的情况下改进用法,使应用更加便捷,值得深思。

4.2.3 扬长避短 如上文所言,现代医学局部用药存在一定的弊端,如何填补现代医学局部治疗的空缺,研发兼顾保护皮肤屏障、抗炎、抗菌、抗氧化和低毒副作用的中药外用制剂,是中药外治治疗慢性手部湿疹亟需解决的问题。通过分析外用制剂的成分和相关通路,也可进一步探究慢性手部湿疹的发病机制,反哺现代医学。

5 结语

本文遍览《黄帝内经》《金匱要略》《外科正宗》《医宗金鉴》《外科全生集》《太平惠民和剂局方》《严氏济生方》等,从“理、法、剂、药、用”的角度,对治疗慢性手部湿疹的古方进行了总结。

从病机而言,慢性手部湿疹多责之于血气凝滞、湿蕴生虫、风血皆燥、太少湿热和燥湿互结。辨证时应首重局部辨证,分晓湿燥,再观体质以辨“瘀、虚、虫、风”之病机,审证求因,祛邪扶正,以求方证对应,药到病除。

从剂型而言,治疗慢性手部湿疹之古方以“汤、散、膏、丸”为主,各有利弊。其中一些剂型的制法对古方革新有一定启示,例如红油膏制作中“煎至砒枯烟绝为度,去砒留油”,是否能更有效地用于砒霜的减毒增效,这些问题值得细细推敲查验。

从方药而言,治疗慢性手部湿疹之古方多用油、铅汞、矾,油者滋腻润肤,铅汞者化瘀生新,矾者燥湿杀虫,正应“润、化、燥”三法。虽然铅、汞、矾之属因毒性已很少被现代临床使用,但古方对慢性手部湿疹病机治法的揭示,也值得思考。

研究古方对慢性手部湿疹的临床治疗和研究具有指导价值,对剂型的改进也有一定的启迪作用。随着医学的发展,中医的疗法亟需应变,以适应现代药物使用谱的变化。现代中医应尽取改良替代之

法,活用减毒增效之加减,更可跳出传统剂型的束缚,更好地守正创新。

参考文献:

- [1] 中国医师协会皮肤科医师分会科学委员会,中国医师协会皮肤科医师分会变态反应性疾病专业委员会,中国手部湿疹科研协作组.中国手部湿疹诊疗专家共识(2021版)[J].中华皮肤科杂志,2021,54(1):19-26.
- [2] QUADE A S, SIMONSEN A B, HALLING A S, et al. Prevalence, incidence, and severity of hand eczema in the general population—a systematic review and Meta-analysis[J]. Contact Dermatitis, 2021, 84(6):361-374.
- [3] MOBERG C, ALDERLING M, MEDING B. Hand eczema and quality of life: a population-based study[J]. Br J Dermatol, 2009, 161(2):397-403.
- [4] 王海霞.慢性湿疹患者的综合性心理护理干预临床效果评价[J].基层医学论坛, 2023, 27(21):70-72.
- [5] ZHENG H, LIANG H, WANG Y, et al. Altered gut microbiota composition associated with eczema in infants [J]. PLoS One, 2016, 11(11): e0166026.
- [6] NIEWIEM M, GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK U. Intestinal barrier permeability in allergic diseases[J]. Nutrients, 2022, 14(9):1893.
- [7] 吴谦.医宗金鉴[M].北京:中国中医药出版社,1994.
- [8] 陈实功.外科正宗[M].天津:天津科学技术出版社,1993.
- [9] 刁庆春,刘毅.湿疹(湿疮)中医诊疗专家共识[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2021, 20(5):517-521.
- [10] 范道长,石瑞舫.路志正论治湿病学术思想探微[J].中国中医基础医学杂志, 2011, 17(3):233-234.
- [11] AGNER T, ELSNER P. Hand eczema: epidemiology, prognosis and prevention[J]. J Eur Acad Dermatol Venerol, 2020, 34(Suppl 1):4-12.
- [12] MOLIN S. Pathogenesis of hand eczema[J]. Hautarzt, 2019, 70(10):755-759.
- [13] BAINS S N, NASH P, FONACIER L. Irritant contact dermatitis[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2019, 56(1): 99-109.
- [14] DUBIN C, DEL DUCA E, GUTTMAN-YASSKY E. Drugs for the treatment of chronic hand eczema: successes and key challenges[J]. Ther Clin Risk Manag, 2020, 16:1319-1332.
- [15] HO J S S, MOLIN S. A review of existing and new treatments for the management of hand eczema[J]. J Cutan Med Surg, 2023, 27(5):493-503.
- [16] 严用和.重辑严氏济生方[M].北京:中国中医药出版社, 2007:180.
- [17] 汪昂.本草备要[M].北京:人民卫生出版社,1965:100.
- [18] 史可,王春燕,位玉蝶,等.白附子标准汤剂的物性参数与化学成分相关性研究[J].中华中医药学刊, 2024, 42(6): 146-153.
- [19] 太平惠民和剂局.太平惠民和剂局方[M].北京:中国中医药出版社,2020:240.
- [20] 刘晓龙,李春燕,肖先,等.黄连主要活性成分及药理作用研究进展[J].新乡医学院学报, 2023, 40(8):784-790.
- [21] 刘雄,赵静,沈霞,等.含铅类中药儿童应禁用[J].内蒙古中医药, 2007, 43(1):65-67.
- [22] 王洪绪.外科全生集[M].上海:上海卫生出版社,1956:121.
- [23] 倪朱谟.本草汇言[M].北京:中医古籍出版社,2005:381.
- [24] 陈思文.润肌膏治疗慢性手部湿疹(血虚风燥型)的临床疗效观察[D].长沙:湖南中医药大学,2022:18.
- [25] 赵萌.加味二矾汤浸泡治疗手部亚急性湿疹的临床疗效观察[D].成都:成都中医药大学,2018:15.
- [26] 吴怡峰,潘陈彬,傅佩骏,等.疯油膏结合热烘疗法治疗手部角化性湿疹的临床观察[J].上海中医药大学学报, 2015, 29(5):49-52.
- [27] 魏璠,杨佼,崔炳南.外用中药润燥止痒方治疗角化型手部湿疹的临床观察[J].世界中西医结合杂志, 2022, 17(2): 315-318.
- [28] 葛一漫,胡一梅,王毅,等.基于h1r、par-2/trpv1痒信号通路探讨马齿苋对急性湿疹的干预作用[J].中国免疫学杂志, 2018, 34(2):210-213.
- [29] SOEBERDT M, KILIC A, ABELS C. Small molecule drugs for the treatment of pruritus in patients with atopic dermatitis[J]. Eur J Pharmacol, 2020, 881:173242.
- [30] 徐维黎,苏习刚,李克娜.药物透皮吸收及临床应用[J].中国医药指南, 2009, 7(10):86-87.

(收稿日期:2024-01-08)